

VIVIEN LEAD MAGNET

A láthatatlan terhelés — HR-vezetők útmutatója demens hozzátartozót ápoló munkavállalókhoz

*Egy üzleti és emberi keret a
szendvicsgeneráció támogatásához*

KÉSZÍTETTE

Stoiber Vivien

Demenciaszakértő · A demenciáról érthetően

DEMENCIAROLERTHETOEN.HU

A láthatatlan terhelés

HR-vezetői útmutató a demenciával élő hozzátartozót ápoló munkavállalókhoz

Nem látszik. De drága. Egy üzleti és emberi keret arról, mit kezdj a szendvicsgeneráció csendes kiégésével — mielőtt felmondással ér véget.

Stoiber Vivien — A demenciáról érthetően

Mielőtt belevágsz

Kedves HR-vezető,

ha ezt a brifet megnyitottad, valószínűleg ismerős a kvartális mondat: „Megint felmondott egy 50 feletti, addig stabil kollégánk. Családi okra hivatkozott, de nem mondta el pontosan, mi történt.”

Ez ma nem ritka. És fontos: ez nem azt jelenti, hogy a céged rosszul bánik az embereivel. Azt jelenti, hogy a céged HR-rendszerének még nincs nyelve arra, mit kezdjen a láthatatlan gondozói teherrel — azzal, amikor egy 40–55 éves, kulcs-munkavállaló otthon demenciával élő szülőt, házastársat ápol, és erről a munkahelyén egy szót sem mond.

A jelenség azért láthatatlan, mert a magyar munkakultúrában a családi gondozás magánügy. A munkavállaló nem szól, mert fél, hogy gyengének látják. A középvezető nem kérdez, mert nem akar tolakodó lenni. A HR pedig csak a számokban látja: emelkedő rövid hiányzások, romló fókusz, megmagyarázhatatlan fluktuáció a legdrágább korosztályban.

A következő tíz oldalon kilenc visszatérő HR-helyzetet veszünk végig. Mindegyiknél négy dolgot nézünk meg:

- **Amit a HR-szemponrendszer lát.**
- **Mi van mögötte.**
- **Amit a céged eddig csinált — és miért nem működik.**
- **Amit helyette tehetsz — és mit érdemes közben mérni.**

Olvasd el. Vidd be a következő People-meetingre. A vezetői csapattal együtt nézzétek át.

Vivien

A három alapelv

Mielőtt a kilenc helyzetről elindulnánk, három mondatot érdemes elől tartani. Ezek mindegyik HR-helyzetben működnek, és ez a három együtt adja a care-aware munkáltatói gyakorlat keretrendszerét.

1. Care-aware leadership — a középvezető a belépési pont

A középvezető az a pont, ahol a gondozói terhelés először találkozik a céggel. Ha ő nem ismeri fel a jeleket, nem tud kérdezni, nem tud rugalmasan reagálni — a HR támogatási rendszere sosem ér el a munkavállalóig. A care-aware vezető nem terapeuta. Meglát, megnevez, és átirányít — a HR-en vagy a külső szakértői csatornán keresztül.

Ha a középvezetők nem kapnak ehhez képzést és scriptet, a jó szándékuk vagy elkerüléssé, vagy határsértéssé válik. Egyik sem segít.

2. Strukturált rugalmasság — nem szívesség, hanem rendszer

A rugalmas munkavégzés nem azonos a rugalmassággal. Az ad-hoc, esetenként megengedett home-office, a hallgatólágos „menj el, ha kell” — nem rendszer, hanem szívesség. A gondozó munkavállalónak rendszer kell, mert a krízisek nem szívességeként érkeznek: a kórházba szállítás, az orvosi vizsgálat, az éjszakai telefon nem kérdezi meg, jó-e most.

Family-care leave, időablak-rugalmasság, váltható részmunkaidős sávok, sabbatical-opció krízisszakaszra — ezek együtt adják a struktúrát. Külön-külön nem elég egyik sem.

3. Külső szakértői támogatás — nem klasszikus EAP

A klasszikus EAP-szolgáltatások (employee assistance program) általános pszichológiai támogatást adnak. A demencia-gondozás specifikus, és sok klasszikus pszichológiai eszköz nem érvényes rá. A „beszélj vele a problémádról” itt nem fog menni — a hozzátartozó már nem tud róla beszélgetni.

A gondozó munkavállalónak konkrét, témaspecifikus szakmai választ kell adni egy konkrét helyzetre: „anyám nem akar fürdeni”, „hogyan beszéljek vele az orvosi vizsgálatról?” Ezt egy általános EAP nem tudja. Demencia-specifikus, diszkrét, on-demand szakértői csatorna kell.

Ha ezt a hármat együtt építed, kiépül a rendszer. Ha bármelyik hiányzik, a másik kettő erőfeszítése részben elveszik.

I. A presenteizmus, aki túl jól dolgozik

Amit a HR-szempontrendszer lát. Tibor 51, 14 éve a cégnél, eddig kiemelkedő teljesítmény. A jelenléti adatokban semmi feltűnő. Az utolsó performance review-n viszont először kapott javítandó minősítést, a 360-as visszajelzésekben elérhetetlen, ingerlékeny, nem hallja meg, amit mondunk neki. A vezetője nem érti — Tibor itt van, dolgozik, nem hiányzik.

Mi van mögötte. Tibor másfél éve gondolja demenciával élő édesanyját. Reggelente átmegy a gyógyszerért, éjszaka kétszer hívja az anyja, mert „valaki bent van a lakásban”. Tibor kimerült, fél, és szégyelli, hogy nem bír. A munkahelyen erről egy szót sem mond — mert nem tartja oda valónak. Ez a klasszikus presenteizmus: jelen van, de a fókusza, problémamegoldó kapacitása, kreatív teljesítménye 20–40%-kal csökkent. Eurocarers (2021) szerint évi 5–12 munkanapnyi termelékenységi veszteség egy gondozó munkavállalónál.

Amit a céged eddig csinált — és miért nem működik. Performance improvement plan, fókusz-tréning, mentorálás. Tibort motiváció-problémaként kezelitek — a vezető szigorít, a HR figyel. Tibor szégyenérzete nő, és még inkább elhallgat. A PIP nem oldja meg, mert a probléma nem a fókuszban van, hanem otthon.

Amit helyette tehetsz. Először a struktúrát tedd láthatóvá, ne a munkavállalót célozd. A belső kommunikációban (intra, all-hands) jelenj meg azzal, hogy a családi gondozás támogatott élethelyzet, és van rá rendszer — family-care leave, on-demand szakértő, rugalmas időablak. Tibornak nem rólad kell hallania először, hanem a lehetőségről. Utána a care-aware középvezetői script: nem rákérdezni az anyára, hanem felajánlani a struktúrát.

Amit érdemes mérni. A presenteizmust közvetlenül nem mérik a HR-rendszerek — de a family-care leave igénybevétele már 3-6 hónap alatt megmutatja, működik-e a rendszer. Cél: az érintettek 40%-a vegyen igénybe legalább 1 napot az első évben. Ha senki sem veszi igénybe, nem azért van, mert nincs rá szükség. Hanem mert nem mertek.

2. A hirtelen kérés rugalmas munkaidőre

Amit a HR-szemponrendszer lát. Egy középvezető, addig 8–17-es ritmusban, hirtelen kéri, hogy 6–14 sávban dolgozhasson. „Családi okok.” A team-lead nem érti, miért — a teljesítménye stabil, nincs csecsemő, nincs költözés. A vezető vonakodva engedélyezi, próbáljuk meg három hónapra. Három hónap múlva a kolléga újra kéri, hogy maradjon a rugalmas sávban.

Mi van mögötte. A munkavállaló reggel 6-tól dolgozik, hogy 14-kor át tudjon menni a demenciával élő édesanyjához — gyógyszerelni, ebédet adni, megnyugtatni az esti nyugtalanság kezdete előtt (a sundowning jelenség a délutáni órákban indul). Ez nem szeszély. Ez az egyetlen módja annak, hogy a munkavállaló a munkáját és a gondozást párhuzamosan tudja vinni — felmondás vagy a fluktuációs lista helyett.

Amit a céged eddig csinált — és miért nem működik. Ad-hoc engedély, három hónapos próbaidő, vezetői majd-meglátjuk. Ez nem rendszer, hanem szívedesség — és a következő vezető-cserénél visszaesik. A munkavállaló minden negyedévben újra kell hogy kiérdemelje a rugalmasságot, és ettől a feszültsége csak nő.

Amit helyette tehetsz. Vezesd be a strukturált időablak-rugalmasságot, dokumentált policy szerint. 6–22 között a munkavállaló a saját időablakát választhatja, megállapodás alapján. Nem privilégium, nem szívedesség — policy. A care-giver szerep, mint élethelyzet, legyen az egyik elfogadott indok, a kisgyerek, a tartós kezelés vagy a továbbtanulás mellett. A vezető nem dönt esetenként — a policy dönt.

Amit érdemes mérni. Hány munkavállaló él rugalmas időablakkal, milyen okból (a kategóriák anonim aggregátban), és ezek közül mennyi a care-giver indokot megjelölő? Ezt az egy számot évente érdemes nézni. Ha 0 — a policy nem létezik a fejekben, csak a Wordben.

3. A teljesítményesés és a megmagyarázhatatlan hibák

Amit a HR-szempontrendszer lát. Egy korábban hibátlan munkavállalónál hirtelen szaporodnak a hibák. Elfelejt egy meetinget, rosszul kalkulál egy excelben, kétszer küld ki egy ügyfél-mailt a rossz mellékletekkel. A team-lead jelzi a HR-nek. A munkavállaló a beszélgetésen csak annyit mond: „fáradt vagyok mostanában, kialszom magam.”

Mi van mögötte. A krónikus alváshiány a gondozó munkavállalónál nem életmód-kérdés. A demenciával élő hozzátartozó éjszakai nyugtalansága (felkelés, zajongás, ajtó-nyitogatás, telefonálás) fizikailag lehetetlenné teszi a folyamatos alvást a háztartásban. 3-6 hónap után a kognitív teljesítmény csökkenése klinikailag mérhető. Ez nem motivációhiány. Ez kimerültség.

Amit a céged eddig csinált — és miért nem működik. Figyelmeztetés, PIP, vagy enyhébb esetben „pihend ki magad a hétvégén”. A munkavállaló a hétvégén sem pihen — a gondozás nem áll meg pénteken 17:00-kor. A hétfő reggel ugyanaz a kimerült állapot, csak most már a céges nyomással súlyosbítva.

Amit helyette tehetsz. Ha a hiba-mintázat hirtelen jelenik meg egy korábban stabil munkavállalónál, a középvezető a care-aware protokoll szerint nem a hibára kérdez rá, hanem felajánlja a struktúrát: „látom, hogy nehezebb időszak van. Tudok-e segíteni abban, hogy ez könnyebb legyen? A cégnél van család-támogatási policy, és van diszkrét, külső szakértői csatorna is, ha valami otthoni helyzet van.” Nem invazív, nem terápiás — kompetens. Utána a munkavállaló dönt.

Amit érdemes mérni. Performance-anomáliák gyakorisága a 40+ korosztályban, és ezek közül hány esetben kezdeményezett a vezető strukturált beszélgetést a 30 napon belül. Ha a 30 napos arány 60% alatt van, a middle-manager képzés nem ment át.

4. A felmondás, amit nem értesz

Amit a HR-szemponrendszer lát. Egy 14 éve a cégnél lévő, addig kiemelkedő, 52 éves szakember felmond. Az exit interview-n családi okok, újragondolom a prioritásaimat. A HR-vezető a 45+ felmondási statisztikákat nézi: a cégátlag 9%, a 45+ korosztály 18%. Ez egy minta, nem véletlen.

Mi van mögötte. Az AARP Caregiving in the Workplace (2024) felmérés szerint a gondozó munkavállalók 32%-a fontolgatta a felmondást a gondozási teher miatt, és 17% ténylegesen csökkentette a munkaóráit vagy felmondott. A felmondás a legrosszabb eszkalációs pont — a munkavállaló azt érzi, nincs más kiút. Pedig lett volna: rugalmas időablak, sabbatical, részmunkaidős sáv, family-care leave. Csak nem tudott róla, vagy nem hitte el, hogy neki is jár.

Egy közép-vezető elvesztésének költsége a magyar piacon a bruttó éves bér 50–150%-a (toborzás, betanítás, tudásvesztés, projektkiesés). Egy 480 fős cégnél évi 4-6 ilyen felmondás 20–30 millió Ft tisztán látható veszteséget jelent — csak a fluktuáció oldaláról.

Amit a céged eddig csinált — és miért nem működik. Exit-bónusz, kontra-ajánlat, maradj-beszéljük-meg. A kontra-ajánlat 80%-ban nem tartja meg a felmondót — mert a probléma nem a fizetés volt, hanem a strukturált rugalmasság hiánya. A munkavállaló nem 20%-kal több fizetést akar, hanem 6 hét sabbaticalt arra a krízisre, amikor az édesanyját intézménybe kell vinni.

Amit helyette tehetsz. Vezesd be a sabbatical-opciót krízisszakaszra: garantált visszatéréssel járó 2–8 hetes szünet (intézménybe-adás, haldoklás, gyász). Ez a megtartás legerősebb eszköze — a munkavállaló nem mond fel, hanem szünetet tart. Kommunikáld ezt előre, ne a felmondás napján. Aki tudja, hogy van sabbatical-csatorna, az nem ír felmondólevelet.

Amit érdemes mérni. 45+ korosztály éves felmondási aránya, exit reason aggregátban — a családi kategória százaléka. Ha a családi kategória 20% felett van, és a sabbatical-igénybevétel évi 0 — a két szám együtt mutatja a rejtett veszteséget.

5. Az „eddig is megoldotta” kultúra

Amit a HR-szemponrendszer lát. Vezetői meetingen, amikor a care-aware programot bemutatod, az egyik osztályvezető megjegyzi: „nézd, az ő anyja már 3 éve beteg, eddig is megoldotta, csinálja tovább. Nem kell ebből rendszert csinálni.” A többiek bólogatnak. A HR-vezető tudja: a kultúra változatlan marad.

Mi van mögötte. A magyar munkakultúrában a családi gondozás bizonyítási harc. Aki kéri a támogatást, gyengének látszik. A vezetők saját életükben sem kéri — nálunk apa is így dolgozott, és ment minden. A bizonyítási kultúra azonban nem azt csinálja, hogy a problémát megoldja — azt csinálja, hogy láthatatlanná teszi, amíg felmondás vagy egészségügyi krízis nem lesz belőle.

Amit a céged eddig csinált — és miért nem működik. HR-irányelv kiadva intranetre, aki kéri kérheti. Senki sem kéri — mert a kultúra azt mondja, hogy nem szabad. Az irányelv léte nem azonos az irányelv használhatóságával. A hozzáférés nem azonos a láthatósággal.

Amit helyette tehetsz. Taboo-csökkentés felülről. A CEO, a HR-vezető, a középvezetők nyilvánosan beszélnek a saját családjukban előforduló gondozási helyzetekről — egyetlen mondat is lehet egy all-hands meetingen, egy belső kommunikációban: „Nálam most a nagymamám diagnózisa miatt nehéz hónapok jönnek, ezért én is élek a family-care leave lehetőséggel.” Ez a láthatóvá tétel — amitől a többi munkavállaló el meri hinni, hogy neki is jár. A kultúra-változás nem policy-ből indul, hanem vezetői mondatból.

Amit érdemes mérni. Az első 6 hónapban az on-demand szakértői csatorna használati száma és a family-care leave igénybevétel. Ha mind a kettő közel nulla — a policy él, de a kultúra még nem. Ez nem a policy hibája — a vezetői kommunikáció hiánya.

6. A care-aware leadership gyakorlata — a fél órás 1-on-1

Amit a HR-szemponrendszer lát. A care-aware program elindult. A middle-managereknek félnapos képzést tartottatok. Két hónap múlva a HR megkérdezi a vezetőket: „Volt-e olyan beszélgetésetek, ahol a struktúrát felajánlottátok?” — a válaszok zömében: nem volt rá alkalom, nem éreztem helyesnek rákérdezni, majd ha érződik, hogy szükséges.

Mi van mögötte. A vezető nem terapeuta — és nem is akar az lenni. A care-aware képzés sokszor a kérdezz-rá-légy-érzékeny üzenetet hagyja, ami pánikba ejti a középvezetőt: mit kérdezzek, hogyan, mi van, ha nem akar beszélni? A bizonytalanság elkerüléssé válik. A képzés tartalmilag jó volt — operatíván használhatatlan.

Amit a céged eddig csinált — és miért nem működik. Soft skill-tréning, empátia-modulok, figyelj-a-jelekre poszterek. Ezek a vezető saját felelősségét növelik, anélkül hogy keretet adnának. Vagy elkerüli a beszélgetést, vagy túlmegy a határon.

Amit helyette tehetsz. Adj scripted protokollt. A fél órás 1-on-1 care-aware verziója nem terapeuta-szerep — három lépés:

1. **Megnevezés.** „Az utóbbi hónapokban érzektem, hogy nehezebb időszak van. Nem akarok belekérdezni — csak jelezni szeretném.”
2. **A struktúra felajánlása.** „A cégnél van család-támogatási policy: family-care leave, rugalmas időablak, on-demand szakértői csatorna, sabbatical-opció krízisszakaszra. Bármelyiket igénybe veheted, és a HR-en keresztül megy, nem rajtam.”
3. **A döntés átadása.** „Nem kell most válaszolnod. Ha úgy érzed, jó, ha tudsz erről, az nekem elég.”

Ez 4–6 perc. Nem terápia. Operatív vezetői gesztus. A munkavállaló a következő héten vagy hónapban dönt — a vezetőnek nem kell tovább kérdezni.

Amit érdemes mérni. Évente kétszer, anonim pulse-survey-ben: „A vezetőd kommunikált-e veled az elmúlt 6 hónapban a cég család-támogatási policy-járól?” Ha az igen-válaszok aránya 30% alatt — a script-protokoll nem ment át. Ha 60% felett — a kultúra mozdult.

7. HR önértékelő mátrix — 10 kérdés

Töltsd ki egyedül vagy a HR-csapattal. Minden kérdés 0-tól 3-ig pontozható.

Maximum 30 pont. Ez nem benchmark — visszajelzés arról, hol tart a céged ma.

#	Kérdés	0	1	2	3
1	Tudja a HR, hány munkavállaló érintett családi gondozásban a cégnél?	nem mértük	becslés van	volt felmérés 2 évnél régebben	aktuális adatunk van
2	Van-e dedikált family-care leave a sima szabadságon felül?	nincs	informálisan	dokumentált policy, korlátozott	dokumentált, méltányos keret
3	A középvezetők kaptak-e képzést a gondozói tünetek felismeréséről?	nem	egy-egy beszélgetésen	évente egy briefing	rendszeres, esetalapú képzés
4	Létezik-e írott protokoll arra, hogyan szólít meg egy vezető egy elhúzódozó hiányzás esetet?	nincs	a vezető eldönti	kész script-vázlat	tesztelt és tréningezett protokoll
5	Tud-e a munkavállaló diszkréten, név nélkül elérni külső demencia-szakértőt a cégen keresztül?	nem	csak általános EAP	demencia-specifikus, ad-hoc	havi keret, dedikált szakértő
6	A cég kommunikációjában (intra, all-hands) szerepel-e a családi gondozás mint támogatott élethelyzet?	nem	egyszer került szóba	évi 1-2 alkalommal	rendszeresen, vezetői hangon
7	Van-e részmunkaidős vagy időablak-rugalmasság, amellyel a gondozó munkavállaló a karrierje sérülése nélkül vált?	nincs	csak kérelemre	strukturált sáv	rugalmas, váltható sáv
8	Méri-e a cég a megtartást a 45+ korosztályban külön, és van-e gondozói faktor a vizsgálatban?	nem	mérjük a kort	mérjük, de nincs gondozói metrika	gondozói metrika is a riportban
9	Van-e a HR-nél naprakész belső erőforrás-térkép a magyar gondozói szolgáltatókról?	nincs	egy-két link	rendezett dokumentum	élő, frissített, ajánlott szolgáltatókkal
10	Szerepel-e a caring employer dimenzió az ESG / DEI / fenntarthatóság riportban?	nem	említés szintjén	van indikátor	mért, közzétett indikátor

Értékelés.

- **0–10 pont — Indulópont.** A cégben még nem épült ki a támogatás. Ez a leggyakoribb induló állapot, és nem szégyen. A 90 napos roadmap pontosan erre az állapokra

készült.

- **11–20 pont — Alapok megvannak.** Vannak részmegoldások, de hiányzik a rendszer-szintű összerendezés. A leggyakoribb hiányzó elem: a középvezetői képzés és a külső szakértői csatorna.
- **21–30 pont — Élvonal.** A cég a magyar piacon a caring employer dimenzióban kiemelkedik. A következő lépés a mérés finomhangolása és a tudás megosztása a piac többi részével (employer branding asset).

8. A 90 napos roadmap

Realisztikus, egy közepes magyar HR-csapat (2-4 fő) által végrehajtható ütemterv. Nem ígéri, hogy 90 nap alatt minden megoldódik — de azt igen, hogy 90 nap múlva a cég rendszerszerűen foglalkozik a kérdéssel.

1. hónap — Felmérés és kickoff

Cél: kép arról, mekkora a teher, és a középvezetők elindítása.

- 1. hét: HR önértékelés (10 kérdéses mátrix), és a vezetői körnek ennek bemutatása. Belső kommunikációs döntés: kit és hogyan informálunk.
- 2. hét: Anonim munkavállalói pulse-survey (5-7 kérdés a gondozói helyzetről). Cél: a 12%-os konzervatív becslést a saját adattal validálni vagy korrigálni.
- 3. hét: Középvezetői kickoff-képzés (félnap). Felismerés, script-protokoll, eskaláció.
- 4. hét: Konzultáció külső demencia-szakértővel — a HR-csapat felkészítése a következő hónapra.

2. hónap — Protokollok és erőforrások

Cél: működő struktúra, írott formában.

- 5. hét: Family-care leave policy megfogalmazása és vezetői jóváhagyás.
- 6. hét: Időablak- és részmunkaidős rugalmasság-szabályzat finomhangolása vagy bevezetése.
- 7. hét: Belső gondozói erőforrás-térkép összeállítása (magyar szolgáltatók, Alzheimer Café-k, otthoni ápolás, demencia-szakértők).
- 8. hét: Az employee on-demand szakértő-csatorna szerződése, kommunikációs anyaga.

3. hónap — Kommunikáció és mérés

Cél: a munkavállalók tudnak a támogatásról, és a HR mérni kezdi a hatást.

- 9. hét: Belső kommunikációs kampány: intra, all-hands szerepeltetés, középvezetői üzenet, vezetői nálam-is-van mondat.
- 10. hét: Első nyilvános gondozói workshop a munkavállalóknak (külső szakértő).
- 11. hét: Mérési keret definiálása (megtartás 45+, family-care leave igénybevétel, hiányzás-trend, workshop-NPS).
- 12. hét: 90 napos retrospektív, és a 6 hónapos terv kialakítása.

90 nap után negyedévente ismétlődő munkavállalói workshop, évi vezetői képzés (refresh), éves anonim gondozói survey, és az ESG / DEI riportban a gondozói metrika közzététele.

9. A kalkuláció — mit kerül, ha nem csinálod

A családi gondozás üzleti költsége három csatornán át jelenik meg: presenteeism (jelenléti munkavégzés, csökkent termelékenységgel), abszентizmus (hiányzás) és fluktuáció (a munkavállaló elvesztése). A három csatorna együtt mérhető — de a HR-rendszerek külön-külön mérik őket, ezért láthatatlan marad.

A három csatorna konzervatív becslése

- Presenteeism — a legdrágább, mert láthatatlan. A gondozó munkavállaló fókusza 20–40%-kal csökkent. Eurocarers (2021): évi 5–12 munkanapnyi termelékenységi veszteség. Magyar kontextusra konzervatívan évi 6 munkanap.
- Abszентizmus — látható, mérhető. Megnövekedett rövid hiányzások (orvosi vizit, gyógyszer-rendezés, krízis). Konzervatív becslés: évi 4 plusz hiányzási nap.
- Fluktuáció — a legritkábban kötik a gondozáshoz. AARP (2024): a gondozó munkavállalók 17%-a ténylegesen csökkenti az óráit vagy felmond. Egy középvezető elvesztése: bruttó éves bér 50–150%-a.

Egy 480 fős cég konzervatív kalkulációja

Egy 480 fős magyar közép vállalat, ahol a munkavállalók 60%-a 35–60 éves, konzervatív 12%-os érintettségi arány alapján:

480 × 60% × 12% ≈ 35 érintett munkavállaló

Egy gondozó munkavállaló éves rejtett vesztesége (konzervatív):

Tétel	Napszám	Napi költség (bruttó+TB)	Éves veszteség / fő
Presenteeism	6 nap	35 000 Ft	210 000 Ft
Abszентizmus	4 nap	35 000 Ft	140 000 Ft
Felmondás kockázata (átlagolva) —	—		~ 250 000 Ft
Becsült éves veszteség / fő			~ 600 000 Ft

35 érintett × 600 000 Ft ≈ 21 millió Ft / év egy 480 fős cégnél, csak a láthatatlan gondozói tehernél.

A láthatatlan költség mellett a látható haszon

A care-aware munkáltatói gyakorlat dokumentált hatásai (Eurocarers Employer Toolkit, AARP 2024):

- Megtartás: 15–20%-kal alacsonyabb felmondási arány a 45+ korosztályban.
- Toborzási előny: a caring employer jelzés a top 5 differenciátor a 40+ jelöltek számára (LinkedIn Talent Trends 2025).
- Engagement: a gondozó munkavállalók engagement-je 25–30%-kal magasabb azokban a szervezetekben, ahol létezik strukturált támogatás.
- ESG / DEI riport-érték: a gondozói támogatás bekerült az EU CSRD szociális indikátorai közé (S1 standard).

Az alábbi eset hipotetikus, több, általunk ismert magyar középállati implementációból összeolvasott — a számok és a folyamatlépések reálisak.

Kiinduló helyzet (Q1). A HR-vezető a 45+ korosztály éves felmondási arányát 18%-on méri (cégátlag 9%). A vezetői interjúkban három felmondó említette a családi okot.

Önértékelő mátrix: 8 pont.

1. hónap. Anonim pulse-survey: a 480 munkavállaló 71%-a válaszol. A 35+ korosztály 19%-a jelez aktív családi gondozói szerepet — ebből 6% kifejezetten demencia-érintett. Ez 22 ember. Középvezetői képzés (28 fő, félnap).
2. hónap. Bevezetik az évi 8 nap family-care leave-et és a 60/80/90% részmunkaidős sávot. Megszerződnek egy demencia-szakértői csatornával: havi 8 óra on-demand + negyedéves workshop.
3. hónap. Első workshop: 41 résztvevő (a cég 9%-a). A vezérigazgató all-hands-en megemlíti a saját édesapja gondozási helyzetét — két mondatban. A következő héten 12 új konzultációs kérelem.

6 hónap múlva. 45+ felmondási arány 18%-ról 12%-ra csökken. Family-care leave éves igénybevétele: 31 munkavállaló, átlagosan 3,4 nap fejenként. Workshop-NPS: +62.

Becsült éves megtakarítás (csak a fluktuáció-csökkenésen): 4 fő $\times$ ~ 5 millió Ft pótlási költség $\approx$ 20 millió Ft / év, a támogatási rendszer éves költsége mellett (~ 3-4 millió Ft).

Mi következik

Ez a brief egy keretet adott. A keret önmagában nem elég — a HR-szervezetnek és a vezetői körnek gyakorolnia kell. Két irány nyitva van innen.

Ha a céged a HR önértékelő mátrixon 15 pont alatt teljesít — érdemes egy 45 perces, diszkrét beszélgetésen átnéznünk a saját helyzeteteket. A beszélgetés ingyenes, és kifejezetten HR-vezetőknek szól. Mit kapsz a 45 percben: visszajelzést az önértékelésedre a magyar közép vállalati benchmarkokhoz mérve; egy konkrét, 90 napos starter-tervet a céged méretére és iparágára szabva; indikatív költségbeclést a 3 pillér implementációjára. Nincs sales-pitch, nincs mindenképpen-csomagot-kell-venned.

Ha a céged 15 pont fölött, és célzott támogatás kell — három csomag van, amelyek külön-külön vagy egymásra építve igénybe vehetők. HR & vezetői workshop (félnapos, max. 20 fő). Munkavállalói workshop sorozat (3 × 90 perc, negyedéves ritmusban). Employee on-demand támogatás (havi 6–12 óra keret, diszkrét, név nélkül). Egy 300–800 fős cég számára indikatív éves szintű kötelezettség 1,8–4,5 millió Ft sávban. A C csomag legfőbb értéke a bizalom: a munkavállaló nem a HR-en keresztül jelentkezik, a cég csak az összesített használati adatot látja.

Foglalás: demenciatanacs.hu/hr-konzultacio — E-mail: info@demenciatanacs.hu

És még valami. Ez a brief azzal indult, hogy *nem látszik, de drága*. A láthatatlan teher kezelése nem költség-tétel, hanem megtartási és márkaérték-beruházás. A változási kísérletek 80%-a azon múlik, hogy a HR-vezető és a felsővezetés elhiszi-e, hogy ez rendszer-kérdés, nem szívesség-kérdés.

Ha eddig elolvastad, akkor te elhiszed.

A megtartás nem juttatáscsomag. Rendszer.

Vivien

Európai és nemzetközi források

- Alzheimer Europe (2024). *Dementia in Europe Yearbook 2024. Estimating the prevalence of dementia in Europe.* Luxembourg.
- Eurocarers (2021). *Enabling carers to care: An EU strategy for carers.* Brussels.
- Eurocarers (2022). *Employer Toolkit for Carers in the Workplace.*
- AARP & National Alliance for Caregiving (2024). *Caregiving in the Workplace: Employer Best Practices.* Washington DC.
- OECD (2023). *Health at a Glance: Europe 2023. Long-term care and informal caregiving chapters.*
- WHO (2023). *Global status report on the public health response to dementia.*
- Carers UK (2023). *Working Carers Toolkit for employers.*

Magyar források

- Központi Statisztikai Hivatal (KSH). *Demográfiai vetítések, 2024. Munkaerőpiaci adatok, 2024.*
- Magyar Alzheimer Társaság. *Demencia-prevalencia becslések.* alzheimer.hu
- Alzheimer Café Magyarország. *Hazai gondozói támogató hálózat.* alzheimercafe.hu

Munkahelyi gyakorlatra vonatkozó kiegészítő anyagok

- LinkedIn Talent Trends (2025). *Candidate priorities by age cohort.*
- EU CSRD (2024). *Corporate Sustainability Reporting Directive — szociális indikátorok S1 standard.*

Megjegyzés. A magnetben szereplő munkavállalói arány- és költségbecslések magyar kontextusra adaptált, konzervatív szakértői vetítések. A saját céged adataival történő finomhangolásra a HR önértékelő mátrix és a 45 perces konzultáció ad keretet.